PROTOCOLLO 8

Valutazione del rachide cervicale nel paziente con DTM

Identificare il contributo cervicale ai sintomi orofacciali

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	DTM con dolore cervicale	10 minuti	Valutazione iniziale

Indicazioni

- ✓ Dolore cervicale associato
- ✓ Cefalea
- ✓ Postura con capo in avanti

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: seduto e poi supino.

Fisioterapista: accanto al paziente, con goniometro o inclinometro.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Osservazione

Valuta postura del capo e delle spalle in piedi e seduto.

2



FASE 2

Mobilità attiva

Flessione, estensione, rotazioni e inclinazioni.

3



FASE 3

Test di flessione-rotazione

Valuta la rotazione C1–C2 in flessione completa.

4



FASE 4

Palpazione

Suboccipitali, trapezio superiore e sternocleidomastoideo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Test flessione-rotazione	positivo sotto i 32° o differenza superiore a 10°
Strumento	goniometro
Tempo	10 minuti

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)

____ / 10

a riposo e in movimento

MOBILITÀ

____°

rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI

Migliorati / Invariati

dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Il rachide cervicale influenza la posizione mandibolare
- ✓ Ricerca il dolore riferito al volto
- ✓ Annota i test positivi

Errori da evitare

- ! Trascurare il collo nel paziente con cefalea
- ! Testare la rotazione senza screening vascolare
- ! Valutare solo in posizione seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Pause posturali	Interrompere ogni 45 minuti il lavoro al computer	durante la giornata lavorativa

! **Nota clinica.** Quando il collo contribuisce ai sintomi, integrare il trattamento cervicale migliora i risultati sui DTM.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.